

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL  
PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)**

|                    |   |                                                                       |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| NO DOKUMEN         | : | UDDP-MK-L2-022                                                        |
| VERSI              | : | 001                                                                   |
| TANGGAL BERLAKU    | : | 28 JUNI 2024                                                          |
| TANGGAL KAJI ULANG | : | 28 JUNI 2026                                                          |
| STATUS DOKUMEN     | : | MASTER: <input type="checkbox"/> SALINAN NO: <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disusun oleh:<br><br>Shaffa Auliyah Hawwa, A.Md. Kes<br>Staff Pemastian Mutu<br>Unit Donor Darah Pusat PMI     | Tanda tangan :<br><br>Tanggal: 21 Juni 2024  |
| Diperiksa oleh :<br><br>Frida Rosita, S.Si., M.Biomed<br>Kasubid Kontrol Dokumen<br>Unit Donor Darah Pusat PMI | Tanda tangan :<br><br>Tanggal: 25 Juni 2024 |
| Disetujui oleh :<br><br>Mega Octavia, S.Si<br>Kasubid Pemastian Mutu<br>Unit Donor Darah Pusat PMI             | Tanda tangan :<br><br>Tanggal: 26 Juni 2024 |
| Disahkan oleh :<br><br>dr. Srihartaty, M.Biomed<br>Manajer Kualitas<br>Unit Donor Darah Pusat PMI              | Tanda tangan :<br><br>Tanggal: 27 Juni 2024 |

DOKUMEN TERKENDALI  
001

|                                                                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI) |                               | Halaman 1 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                              | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                               |

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini sebagai petunjuk dalam menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi di pelayanan Kesehatan, menurunkan angka infeksi Nosokomial/*Healthcare Associated Infections* (HAIs) dan memutus rantai penyakit infeksi, akibat pelayanan yang tidak sesuai standar di pelayanan Unit Donor Darah Pusat.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh personil atau pegawai UDD Pusat PMI yang berkaitan dengan semua unit yang berisiko terpapar kejadian infeksi, memutus rantai penyebaran infeksi di tempat kerja, Pengendalian dan pencegahan infeksi juga dilakukan oleh semua yang berada di Unit Donor Darah Pusat. Pengendalian dan Pencegahan Infeksi juga melibatkan pihak ketiga yang terkait dengan memutus rantai penyebaran infeksi di pelayanan Unit Donor Darah Pusat dan kebersihan lingkungan untuk mencegah rantai penyebaran infeksi.

3. Persyaratan sistem mutu

3.1. Kebersihan Tangan atau *Hand Hygiene*

- 3.1.1. Pastikan semua petugas kesehatan sudah memahami 5 momen (waktu) serta 6 langkah kebersihan tangan dan mampu melaksanakan dengan benar
- 3.1.2. Seluruh personil harus mencuci dan mendesinfeksi tangan secara higienis, sebelum dan setelah pengambilan, pemeriksaan atau pengolahan darah
- 3.1.3. Jika terdapat luka/lecet maka tutupi luka dengan plester anti air
- 3.1.4. Mencuci tangan menggunakan air mengalir yang berasal dari kran dengan pembuangan atau bak penampung yang memadai
- 3.1.5. Mencuci tangan menggunakan sabun atau larutan antiseptik dalam bentuk cair (Spektrum Antimikrobia dan Karakteristik Bahan Antiseptik).
- 3.1.6. Gunakan bahan yang mengandung alkohol untuk mendekontaminasi tangan secara rutin, bila tangan tidak jelas terlihat kotor
- 3.1.7. Prinsip dari 6 langkah *hand hygiene* antara lain:
  - 3.1.7.1. Siapkan *Handrub* (kemasan siap pakai dari pabrik atau campuran 97 ml alkohol 70% dalam 3 ml gliserin, jika dibuat secara massal tidak lebih dari 50 liter per sekali pembuatan). Jika sudah tersedia dalam produk siap pakai maka ikuti instruksi pabrik cara penggunaannya
  - 3.1.7.2. Dilakukan dengan menggosokkan tangan menggunakan cairan antiseptik (*handrub*) atau dengan air mengalir dan sabun antiseptik (*handwash*)
  - 3.1.7.3. *Handrub* dilakukan selama 20-30 detik sedangkan *handwash* 40-60 detik.





|                            |                                                                                   |                               |                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Unit Donor Darah Pusat | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 2 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                            | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                               |

- 3.1.7.4. Setiap 5 kali melakukan *handrub* sebaiknya diselingi 1 kali *handwash*.

3.1.8. Tata cara *hand hygiene* sesuai dengan WHO, yaitu dengan 6 (enam) langkah.

3.1.9. Cuci tangan dilakukan dalam 5 (lima) kondisi, antara lain:

3.1.9.1. Sebelum kontak dengan pengguna layanan/spesimen.

3.1.9.2. Sebelum Tindakan Aseptik.

3.1.9.3. Setelah kena cairan tubuh pengguna layanan/spesimen.

3.1.9.4. Setelah kontak dengan pengguna layanan/spesimen.

3.1.9.5. Setelah kontak lingkungan.
- 3.2. Cuci Lengan Donor dan Desinfeksi lengan donor

3.2.1. Cuci lengan donor harus dilakukan pada donor yang sudah lolos seleksi donor

3.2.2. Pastikan donor mengetahui tata cara cuci lengan donor

3.2.3. Fasilitas cuci lengan donor harus tersedia bisa menggunakan *handwash* (air mengalir dengan sabun) atau bisa menggunakan *handrub antiseptic*

3.2.4. Pastikan di setiap tempat fasilitas cuci lengan donor terdapat langkah-langkah cuci lengan donor agar donor mudah melakukan cuci lengan donor dengan benar

3.2.5. Pastikan petugas aftap men-*checklist* pada formulir donor, ketika donor sudah selesai melakukan cuci lengan donor dengan benar

3.2.6. Untuk di mobile unit, ketika survey lokasi donor pastikan ada fasilitas untuk donor cuci tangan dan cuci lengan donor, jika tidak ada bisa menggunakan *handrub* cuci tangan dan cuci lengan donor juga bisa menggunakan tisu basah *antiseptic* yang sudah lolos diuji swab pada bagian uji mutu

3.2.7. Setelah donor selesai melakukan cuci lengan donor, petugas melakukan desinfeksi lengan donor untuk meminimalkan risiko kontaminasi bakteri pada area lengan yang ditusuk

3.2.8. Desinfeksi lengan donor dengan pertama menggunakan *povidone iodine* dan kedua *alcohol swab 70%*, tunggu minimal 30 detik baru lakukan penusukan pada vena donor.

3.2.9. Desinfeksi lengan donor juga dilakukan uji swab lengan donor oleh bagian uji mutu
- 3.3. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.3.1. APD harus digunakan sesuai dengan risiko paparan: petugas kesehatan harus menilai apakah mereka benar atau tidak berisiko terkena darah, cairan tubuh, eksresi atau sekresi agar dapat menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan risiko.



|                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                       |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Patung Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                                       | Halaman 3 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                                         | <b>Bidang<br/>Manajemen Kualitas</b>                                              | <b>Sub Bidang<br/>Kontrol Dokumen</b> |                                                                                                                               |

- 3.3.2. Semua APD yang akan digunakan harus memenuhi standar keamanan, perlindungan dan keselamatan pasien atau petugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.3.3. Hindari kontak antara APD yang terkontaminasi (bekas) dan permukaan pakaian atau lingkungan pelayanan kesehatan, buang APD bekas pakai yang sesuai dengan tempat limbah dan standar yang ditetapkan.
- 3.3.4. Tidak berbagi APD yang sama antara dua petugas/individu
- 3.3.5. APD di UTD meliputi baju laboratorium, apron, pembungkus kepala sekali pakai, kaca mata pelindung, masker, sarung tangan sekali pakai, sarung tangan sekali pakai, sepatu tertutup khusus untuk di laboratorium atau pembungkus sepatu sekali pakai dan sepatu boot
- 3.3.6. Jenis APD untuk setiap jenis kegiatan:

| No. | Jenis Kegiatan                                                           | Jenis APD                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengambilan Darah                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Baju laboratorium</li> <li>Sarung tangan sekali pakai</li> <li>Masker (untuk menghindari kontaminasi dari petugas)</li> </ul>                                                                                                                          |
| 2.  | Pemeriksaan Laboratorium (IMLTD, Konfirmasi Golongan Darah dan Uji Mutu) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Baju laboratorium</li> <li>Sepatu tertutup khusus untuk laboratorium atau pembungkus sepatu sekali pakai</li> <li>Sarung tangan sekali pakai</li> <li>Kacamata pelindung</li> <li>Penutup kepala (bagi yang tidak berhijab)</li> <li>Masker</li> </ul> |
| 3.  | Pengolahan Komponen Darah, Produk rilis, Penyimpanan dan Distribusi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Baju laboratorium</li> <li>Sepatu tertutup khusus untuk laboratorium atau pembungkus sepatu sekali pakai</li> <li>Sarung tangan sekali pakai</li> <li>Pembungkus kepala sekali pakai</li> </ul>                                                        |
| 4.  | Logistik, Bahan Baku Fraksionasi Plasma dan Locket                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sarung tangan</li> <li>Masker</li> <li>Sepatu boot (jika memasuki coldroom/freezer room)</li> <li>Sarung tangan tebal (jika memasuki coldroom/freezer room)</li> <li>Jaket tebal (jika memasuki coldroom/freezer room)</li> </ul>                      |

DOKUMEN TERKONTROL  
 Salinan No. 001

MASTER



|                                                                                                                                           |                                                                                   |                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 4 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                               |

| No. | Jenis Kegiatan                                   | Jenis APD                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Pengunjung ke area yang telah disebutkan di atas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• APD yang digunakan oleh pengunjung adalah APD <i>disposable</i> dan sesuai area kegiatan yang dikunjungi</li> </ul>                                                           |
| 6.  | <i>Cleaning Service</i>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju laboratorium</li> <li>• Apron</li> <li>• Sepatu boot</li> <li>• Sarung tangan latex</li> <li>• Kacamata pelindung</li> <li>• Penutup kepala</li> <li>• Masker</li> </ul> |

- 3.3.7. Personil harus mendapatkan pelatihan dan memahami cara mengenakan semua perlengkapan dan bahan APD seperti cairan untuk mencuci tangan, cairan pembersih, dan disinfektan harus divalidasi dan disetujui.
- 3.3.8. APD terdiri dari 2 jenis yaitu APD sekali dan APD yang bisa dipakai ulang.
- 3.3.9. APD sekali pakai adalah APD yang hanya dipakai satu kali oleh petugas kemudian dibuang yaitu Sarung tangan, Apron sekali pakai, Penutup kepala sekali pakai, Masker.
- 3.3.10. APD yang bisa dipakai ulang terdiri baju laboratorium, kaca mata pelindung, apron, sepatu laboratorium dan sepatu boot.
- 3.1.10.1. Baju laboratorium, diganti setiap hari. Khusus untuk petugas MU, baju Laboratorium Bebas tidak berpatokan dari warna. Kaca mata pelindung, sepatu laboratorium dan sepatu boot didesinfeksi menggunakan cairan desinfektan setelah pemakaian oleh masing-masing petugas
- 3.3.11. Lakukan kebersihan tangan setiap kali melepas APD ketika sudah selsai melakukan tindakan medis atau akan melakukan prosedur lain dnegan berbeda pasien/donor.

3.4. Kewaspadaan Transmisi

- 3.4.1. Kewaspadaan transmisi kontak adalah tindakan kewaspadaan yang dirancang untuk mencegah terjadinya infeksi yang ditularkan melalui kontak langsung (menyentuh kulit, lesi, sekresi atau cairan tubuh yang terinfeksi) atau kontak tidak langsung (melalui tangan petugas atau orang lain saat menyentuh peralatan, air, makanan, atau sarana lain). Penyakit yang dapat ditularkan melalui transmisi kontak antara lain HIV/AIDS, Hepatitis B, Diare, Scabies, dan lain-lain.



|                                                                                                                                           |                                                                                   |                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 5 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                               |

- 3.4.1.1. Pastikan semua petugas mematuhi prosedur kewaspadaan standar yang telah ditetapkan.
  - 3.4.1.2. Tidak menyentuh atau hindari memegang sesuatu secara langsung tanpa memperhatikan jenis pajanan dan indikasi penggunaan APD.
  - 3.4.1.3. Batasi orang yang berada di ruangan pengambilan darah, laboratorium, ruang pengolahan darah, pemeriksaan sampel, dan lain-lain.
  - 3.4.1.4. Segera lakukan pembersihan setiap menemukan sumber penularan darah, cairan, tubuh, kotoran, sekresi, dan lain-lain.
  - 3.4.1.5. Dekontaminasi setiap peralatan yang digunakan untuk donor atau sampel darah pasien baik kontak secara langsung maupun tidak langsung.
  - 3.4.1.6. Jika terjadi wabah, perhatikan petunjuk, aturan, pedoman, atau ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan wabah yang dikeluarkan pemerintah atau gugus tugas yang ditetapkan, misalnya dengan jaga jarak baik antara petugas dengan donor maupun pengguna layanan.
- 3.4.2. Kewaspadaan transmisi droplet adalah tindakan kewaspadaan untuk menghindari penularan penyakit infeksi melalui droplet (sekresi yang dikeluarkan melalui pernapasan) selama batuk, bersin, atau berbicara. Karena sifatnya droplet maka biasanya tidak akan terpercik jauh, tidak melayang di udara namun akan jatuh pada suatu permukaan benda. Berbagai studi menunjukkan bahwa mukosa hidung, konjungtiva dan mulut merupakan portal masuk yang rentan untuk virus penyebab infeksi pernapasan. Penyakit infeksi yang saat ditularkan melalui droplet antara lain: influenza, ISPA, SARS, COVID-19 pertusis dan lain-lain.
- 3.4.2.1. Pastikan semua petugas mematuhi produser kewaspadaan standar yang telah ditetapkan saat akan memberikan layanan.
  - 3.4.2.2. Lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan donor atau sampel pasien dan lingkungan sekitar dengan menggunakan air dan sabun atau cairan *handrub* berbasis alkohol.
  - 3.4.2.3. Gunakan masker jika ada gangguan saluran pernapasa (flu, batuk, dan lain-lain).
  - 3.4.2.4. Donor, keluarga pasien, pengunjung harus diajarkan kebersihan tangan dan kebersihan pernapasan atau etika batuk.





|                                                                                                                                        |                                                                                   |                               |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 6 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                        | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                               |

3.4.2.5. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai jenis paparan dan indikasi.

- Masker bedah dan lakukan *fit test* untuk meyakinkan masker tidak bocor dan tertutup rapat.
- Saat melepaskan, tidak menyentuh area yang terkontaminasi setelah keluar dari ruang pelayanan, buang ke limbah infeksius dan segera lakukan kebersihan tangan dengan sabun dan air mengalir.
- Pertimbangkan untuk menggunakan masker N95 pada tindakan yang menghasilkan aerosol

3.4.3. Kewaspadaan transmisi udara (*airbone*) adalah tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah penyebaran infeksi yang ditularkan melalui udara dengan menghirup atau mengeluarkan mikroorganisme dari saluran napas. Secara teoritis partikel yang berukuran  $\leq 5$  cm dikeluarkan dari saluran pernapasan dan dapat tetap melayang di udara untuk beberapa waktu. Sumber penularan juga dapat dihasilkan dari tindakan yang menghasilkan aerosol, penghisapan cairan, induksi dahak atau endoskopi. Penyakit infeksi yang bisa ditularkan melalui udara antara lain; TB, virus (flu, COVID-19, SARS, campak, varicella, dan lain-lain).

3.4.3.1. Lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan donor, sampel donor, dan lingkungan dengan menggunakan air dan sabun atau cairan *handrub* berbahan dasar alkohol.

3.4.3.2. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai indikasi, sebagai berikut:

- Gunakan masker bedah atau masker N95 (respiratorik) dan yakinkan penggunaannya tertutup rapat (*fit test*) serta lepaskan tanpa menyentuh area yang terkontaminasi setelah keluar dari kamar perawatan.
- Gunakan kaca mata/pelindung wajah (*face shield*) sesuai jenis risiko paparan *airbone*.
- Gunakan gaun/jas jika akan terjadi risiko paparan kontaminasi pada tubuh atau pakaian petugas.
- Gunakan sarung tangan jika akan terjadi kontaminasi pada tangan.

3.4.3.3. Gunakan ruangan dengan ventilasi tekanan negatif, jika tidak memungkinkan dapat menggunakan ventilasi tekanan mekanik atau ventilasi natural dan pintu harus selalu tertutup.



|                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                       |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                                       | Halaman 7 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                                         | <b>Bidang<br/>Manajemen Kualitas</b>                                              | <b>Sub Bidang<br/>Kontrol Dokumen</b> |                                                                                                                               |

- 3.4.3.4. Lakukan edukasi kepada pendamping/keluarga agar menjaga kebersihan tangan dan menjalankan kewaspadaan isolasi untuk mencegah penyebaran infeksi di antara mereka sendiri ataupun kepada donor lain.
- 3.4.3.5. Pembersihan dan desinfeksi ruangan yang setelah seleksi donor pengambilan donor dan pemeriksaan sampel donor

### 3.5. Kebersihan atau pengendalian lingkungan

Adalah upaya mengendalikan lingkungan melalui perbaikan mutu air, udara/ventilasi permukaan lingkungan, desain, dan konstruksi bangunan. Tujuannya untuk mencegah transmisi mikroorganisme dari pasien atau pengguna layanan ke petugas atau sebaliknya akibat pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang tidak sesuai dengan standar PPI.

Prinsip dasar pembersihan lingkungan:

- 3.5.1. Semua permukaan horizontal di tempat pelayanan yang disediakan untuk donor harus dibersihkan setiap hari atau bila terlihat kotor.
- 3.5.2. Permukaan meja pemeriksaan donor atau peralatan lainnya yang bersentuhan langsung segera dibersihkan dan didesinfeksi untuk pemeriksaan yang berbeda.
- 3.5.3. Pengunjung yang datang ke fasilitas kesehatan dengan sepatu atau sandal yang kotor (bercampur tanah atau lumpur) harus membersihkan terlebih dahulu sebelum masuk (tidak membuka sepatu atau sandal saat masuk).
- 3.5.4. Semua peralatan pembersih harus selalu dibersihkan dan dikeringkan setelah digunakan.
- 3.5.5. Tempat-tempat di sekitar donor, pengunjung dan lain-lain harus bersih dari peralatan dan perlengkapan yang tidak digunakan, sehingga memudahkan pembersihan menyeluruh setiap hari.

Kebersihan dan pengendalian Lingkungan meliputi:

#### 3.5.1. Air

##### 3.5.1.1. Sistem Air Bersih

- Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem pengalirannya.
- Sumber air bersih diperoleh langsung dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya dengan baku mutu yang memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





|                                                                                                                                           |                                                                                   |                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 8 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                               |

- Tempat penambungan air bersih harus dilakukan perawatan kontaminasi, misalnya untuk tangki utama, laboratorium, pelayanan donor.

#### 3.5.1.2. Persyaratan Kesehatan Air

- Sistem air bersih untuk keperluan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diperoleh dari perusahaan air minum, sumber air tanah, air hujan, atau sumber lain yang telah dioleh sehingga memenuhi persyaratan kesehatan.
- Memenuhi persyaratan mutu air bersih, memenuhi syarat fisik kimia, bakteriologis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Distribusi air ke ruang-ruang menggunakan saran perpipaian dengan tekanan positif.
- Sumber air bersih dan saran distribusinya harus bebas dari pencemaran fisik, kimia, dan bakteriologis.
- Tersedia air dalam jumlah yang cukup.

#### 3.5.1.3. Sistem pengelolaan limbah cair medis dan non medis.

- Tersedia sistem pengolahan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak kontrol untuk menjaga kemiringan saluran minimal 1%.

### 3.5.2. Ventilasi Ruangan

3.5.2.1. Bangunan fasilitas pelayanan kesehatan harus mempunyai udara yang baik meliputi ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan yang optimal apabila diperlukan, dengan memperhatikan catatan berikut ini:

- Sistem ventilasi yang menggunakan peralatan mekanik untuk mengalirkan dengan mensirkulasi udara di dalam ruangan secara paksa untuk menyalurkan/menyedot udara ke arah tertentu sehingga terjadi tekanan udara positif dan negatif dengan menggunakan *exhaust fan*, kipas angin berdiri atau duduk
- Sistem ventilasi alamiah adalah mengalirkan udara dari luar ke dalam gedung dan sebaliknya melalui pintu dan jendela terbuka, serta *skylight* (bagian atas ruangan yang bisa dibuka/terbuka)
- Sebaiknya ventilasi alamiah dengan menciptakan aliran udara silang (*cross ventilation*) dan pastikan arah angin tidak membahayakan petugas atau donor

DOKUMEN TERKENDALI  
Salinan No. 001

MASTER

|                                                                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI) |                               | Halaman 9 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                              | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                               |

- Ventilasi gabungan memadukan penggunaan ventilasi mekanis dan alami. Jenis ventilasi ini dibuat dengan pemasangan *exhaust fan* untuk meningkatkan tingkat pergantian udara di dalam kamar
- 3.5.2.2. Bangunan fasilitas pelayanan kesehatan harus mempunyai pintu bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami, bukaan minimal 15% dari luas total lantai
- 3.5.2.3. Besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang di bangunan FTKP minimal 6-12x pertukaran udara per jam dan untuk kamar mandi atau WC 10x pertukaran udara per jam
- 3.5.2.4. Penghawaan dalam ruang perlu memperhatikan 3 elemen dasar yaitu:
- Jumlah udara luar bermutu baik di mana ventilasi harus dapat mengatur pertukaran udara (*air change*) sehingga ruangan tidak terasa panas, tidak terjadi kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding, atau langit-langit, masuk dalam ruang pada waktu tertentu
  - Pada area umum dalam gedung aliran udara seharusnya dari area bersih ke area terkontaminasi sehingga terjadi distribusi udara dari luar ke setiap bagian dari ruang dengan cara yang efisien
  - Setiap ruangan diupayakan agar terjadi proses udara di dalam ruangan bergerak sehingga terjadi pertukaran antara udara di dalam ruang dengan udara dari luar
- 3.5.2.5. Pemilihan sistem ventilasi yang alami, mekanik atau campuran, perlu memperhatikan kondisi lokal seperti struktur bangunan, cuaca, biaya, dan mutu udara
- 3.5.2.6. Tersedia toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- 3.5.3. Konstruksi Bangunan
- 3.5.3.1. Desain bangunan
- Bentuk denah bangunan simetris dan sederhana untuk mengantisipasi kerusakan apabila terjadi gempa
  - Tata ruang bangunan harus mempertimbangkan sirkulasi udara dan pencahayaan
  - Tata letak bangunan (*site plan*) dan tata ruang dalam bangunan harus mempertimbangkan zonasi berdasarkan tingkat risiko penularan penyakit, zonasi berdasarkan





|                                                                                                                                                    |                                                                           |                               |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang<br>Marah<br>Indonesia<br><br>Unit Donor Darah<br>Pusat | STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI) |                               | Halaman 10 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                                    | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                              | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

privasi dan kedekatan hubungan fungsi antar ruang pelayanan

- Tinggi rendah banguann harus dibuat tetap menjaga keserasian lingkungan dan pencegahan banjir
- Aksesibilitas di luar dan di dalam bangunan harus mempertimbangkan kemudahan bagi semau orang termasuk penyandang cacat dan lanjut usia
- Bangunan FTKP harus menyediakan area parkir kendaraan dengan jumlah area yang proposional disesuaikan dengan peraturan daerah setempat.
- Perancangan pemanfaatan tata ruang dalam bangunan harus efektif sesuai dengan fungsi-fungsi pelayanan.
- Permukaan lantai terbuat dari bahan yang kuat, halus, kedap air, mudah dibersihkan, tidak licin, permukaan rata tidak bergelombang dan tidak menimbulkan genangan air dan dianjurkan berwarna terang, pertemuan antara dinding serta lantai berbentuk melengkung supaya mudah dibersihkan dan dianjurkan menggunakan vinyl terutama di ruangan tindakan dan ruanagan pemeriksaan sampel donor, ruang pengolahan darah, dan laboratorium termasuk ruang penyimpanan steril.
- Dinding harus mudah dibersihkan, tahan cuaca, tidak mudah berjamur berpori dan pertemuan dinding tidak bersiku yang dapat menyimpan debu.
- Permukaan dinding seharusnya tidak dipasang assesoris yang akan menjadi tempat akumulasi debu dan sulit untuk dibersihkan jika diperlukan maka sebaiknya dilapisi oleh bahan yang datar mudah dibersihkan (misalnya dilapisi kaca pada lukisan atau media informasi) dan tidak menempelkan kertas-kertas informasi pada dinding.
- Komponen langit-langit berwarna terang, mudah dibersihkan dan tidak memiliki lekukan atau berpori yang dapat menyimpan debu

3.5.3.2. Persyaratan kehandalan bangunan, harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.3.3. Sistem pencahayaan:

- Bangunan fasilitas pelayanan kesehatan harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan.
- Pencahayaan harus didistribusikan rata dalam ruangan.

DOKUMEN TERKENDALI  
Salinan No: 001

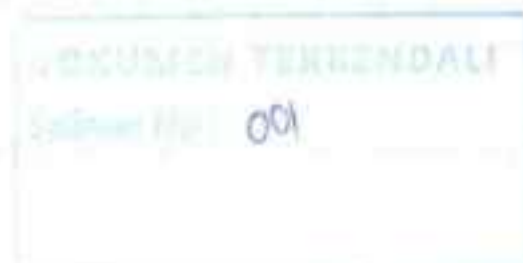
REVISI

|                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                                       | Halaman 11 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                                         | <b>Bidang<br/>Manajemen Kualitas</b>                                              | <b>Sub Bidang<br/>Kontrol Dokumen</b> |                                                                                                                                |

- Lampu-lampu yang digunakan diusahakan dari jenis hemat energi.

3.5.3.4. Berikut penataan barang dan lingkungannya:

- Pastikan semua benda atau barang tertata dengan baik dan tersimpan pada tempatnya.
- Penyimpanan barang atau benda tersusun sesuai jenis barang.
- Pastikan bahwa area bersih dan area kotor terpisah dan berbatas tegas sehingga tidak menimbulkan kontaminasi dan ketidaknyamanan atau risiko kecelakaan kerja.
- Penempatan tempat limbah di ruangan pelayanan pada tempat yang aman dan tidak berada di bawah meja tindakan atau tempat tidur donor.
- Tidak dianjurkan menggunakan karpet atau menempatkan bunga hidup atau bunga plastik atau aquarium di ruang pelayanan donor kecuali petugas mampu membersihkannya terpapar secara langsung pada benda mati (dinding, lantai, permukaan meja, dan lain-lain), misalnya klorin 0,5% untuk pembersihan tumpahan darah atau cairan tubuh atau klorin pengenceran 0.05% untuk pembersihan rutin permukaan, detergen atau cairan pemutih (1:99 cc air) atau hidrogen peroksida 8% untuk pembersihan rutin.
- Pembersihan lingkungan pelayanan kesehatan menggunakan trolly khusus, minimal menggunakan 2 (dua) buah ember yang memiliki alat pemerasan kain lap pel secara otomatis tanpa bersentuhan langsung dengan tangan dan selalu dicuci agar tetap dalam kondisi bersih.
- Petugas kesehatan dalam melakukan pembersihan lingkungan harus mengenakan APD untuk melindungi dari risiko terpajan benda-benda infeksius, benda tajam, cairan infeksius.
- Pembersihan tumpahan dan percikan. Jika ada cairan tubuh, darah, muntahan, percikan ludahan, darah atau eksudat luka pada permukaan lantai, dinding atau tirai pembatas dibersihkan menggunakan spill kit. Spill kit berisi:
  - Spill Kit Infeksius, berisi: Topi, sarung tangan, kacamata, masker, serok, dan sapu kecil, cairan detergen, cairan klorin 0.5% dan kain perca/tisu/koran bekas, plastik warna kuning.





|                                                                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI) |                               | Halaman 12 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                              | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

- o Spill Kit B3, berisi: topi, sarung tangan, kacamata, masker, gaun/jas lab, seok dan sapu kecil, detergen, laturan tertentu berdasarkan bahan kimianya, dna kain perca/tisu/koran bekas, plastik warna coklat.

3.6. Pengelolaan Peralatan

Pengelolaan peralatan perawatan alat medis adalah proses pengelolaan dekontaminasi dan pengemasan berdasarkan kategori kritikal, semi kritikal, dan non kritikal. Yang bertujuan untuk mencegah peralatan cepat rusak, menjaga tetap dalam keadaan terdekontaminasi sesuai kategorinya menetapkan produk akhir yang sudah steril dan aman serta tersedianya peralatan alat medis lainnya dalam kondisi bersih dan steril saat dibutuhkan.

3.6.1. Menggunakan Alat Pelindung Diri

Petugas memakai APD sesuai indikasi dan jenis paparan terdiri dari topi, gaun/apron/jas lab, masker, sarung tangan, dan sepatu tertutup.

3.6.2. Proses Pre-Cleaning

Semua peralatan atau alat medis yang telah digunakan pertama kali dilakukan pembersihan awal (*pre-cleaning*) dengan merendam seluruh permukaan peralatan kesehatan yang menggunakan enzimatik 0,8% atau detergen atau sesuai Instruksi pabrikan selama 10-15 menit untuk menghilangkan noda darah, cairan tubuh.

3.6.3. Pembersihan atau pencucian

Proses ini terdiri dari mencuci sepenuhnya dengan sabun atau detergen dan air atau menggunakan enzim, kemudian membilas dengan air bersih dan dikeringkan. Pembersihan dapat dilakukan sebagai berikut:

3.6.3.1. Pembersihan manual dengan menggunakan sikat (sesuai kebutuhan) atau yang disarankan oleh produsen alat, lalu bilas dengan air mengalir dengan suhu 40°C - 50° C, lebih disarankan menggunakan air deionisasi atau air sulingan. Selanjutnya dicuci, dibilas air mengalir kemudian tiriskan (keringkan) untuk proses selanjutnya.

3.6.3.2. Pembersihan mekanik dengan menggunakan mesin cuci khusus untuk meningkatkan produktivitas, lebih bersih dan lebih aman untuk petugas. Pembersih Ultrasonic melepas semua kotoran dari seluruh permukaan alat atau instrumen.

3.6.4. Proses pengemasan

Pastikan semua peralatan yang akan disterilkan dilakukan pengemasan dengan membungkus semua alat-alat untuk menjaga keamanan dan efektivitas sterilisasi dengan menggunakan pembungkus kertas khusus atau kain (linen) dengan prinsip sebagai berikut:

3.6.4.1. Produser pengemasan harus mencakup; label nama alat, tanggal pengemasan, metode sterilisasi, tipe dan ukuran alat



|                                                                                                                                           |                                                                                   |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 13 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

- yang dikemas, penempatan alat dalam kemasan, dan penempatan indikator kimia eksternal dan internal (untuk memastikan bahwa alat tersebut sudah dilakukan sterilisasi).
- 3.6.4.2. Pengemasan sterilisasi harus dapat menyerap dengan baik dengan menjangkau seluruh permukaan kemasan dan isinya.
- 3.6.4.3. Kemasan harus mudah dibuka dan isinya mudah diambil saat akan digunakan tanpa menyebabkan kontaminasi.
- 3.6.4.4. Harus dapat menjaga isinya tetap steril hingga kemasan dibuka dan dilengkapi masa kedaluwarsa.
- 3.6.4.5. Kemasan harus mudah dibuka, isinya mudah diambil tanpa menyebabkan kontaminasi dan dapat menahan mikroorganisme, kuat, tahan lama, mudah digunakan tidak mengandung bahan beracun segelnya baik.
- 3.6.4.6. Bahan untuk pengemasan dapat berupa: bahan kertas film, bahan plastik, atau bahan kain (linen).
- 3.6.5. Sterilisasi pada peralatan kritis
- Sterilisasi peralatan kritis dapat menggunakan autoklaf atau panas kering adalah proses menghilangkan semua mikroorganisme (bakteria, virus, fungi, dan parasit) termasuk endospora dengan menggunakan uap tekanan tinggi, panas kering (oven).
- 3.6.5.1. Menggunakan sterilisasi dengan pemansan uap (*Steam sterilization or autoklaf*). Proses sterilisasi dengan autoklaf membutuhkan waktu 30 menit dihitung sejak suhu mencapai 121°C
- 3.6.5.2. Menggunakan proses sterilisasi panas kering pada temperatur 340°F (170°C) dalam waktu 1 jam atau temperatur 320°F (160°C) dalam waktu 2 jam.
- 3.6.6. Proses desinfeksi peralatan semi kritis
- 3.6.6.1. Proses DTT (Dekontaminasi Tingkat Tinggi) dengan perendaman dilakukan menggunakan cairan desinfektan (*Sodium Hypochlorite 5,25%* yang ada di pasaran) atau *Glutaraldehyde 2%* atau *Peroxide Hydrogen 6%* selama 15 - 20 menit.
- 3.6.6.2. Proses DTT dengan cara perebusan dan pengukusan dilakukan dalam waktu 20 menit dihitung setelah air mendidih atau sampai terbentuknya uap yang diakibatkan air yang mendidih.
- 3.6.6.3. Uap air panas pada 100°C akan membunuh semua bakteri, virus, parasit, dan jamur dalam 20 menit.
- 3.6.7. Proses desinfeksi peralatan Non Kritis
- 3.6.7.1. Pencucian dilakukan dengan detergen dan air mengalir kemudian keringkan dengan cara digantung. Misalnya manset tensimeter dan lain-lain.

DOKUMEN TERKONTROL  
Salinan No: 001

APR 2025



|                                                                                                                                               |                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Palang Merah Indonesia</p> <p>Unit Donor Darah Pusat</p> | <p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b></p> |                                       | <p>Halaman 14 dari 28</p> <p>Nomor : UDDP-MK-L2-022</p> <p>Versi : 001</p> <p>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024</p> <p>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026</p> |
|                                                                                                                                               | <p>Bidang<br/>Manajemen Kualitas</p>                                                     | <p>Sub Bidang<br/>Kontrol Dokumen</p> |                                                                                                                                                       |

- 3.6.7.2. Desinfeksi dilakukan dengan alkohol swab 70%, misalnya stetoskop, termometer, dan lain-lain.
- 3.6.7.3. Pembersihan dilakukan menggunakan kain bersih yang sudah dilembabkan (disemprot) dengan cairan klorin 0,05%, gosok dan lab semua permukaan yang dibersihkan, misalnya permukaan tempat tidur, meja, dan lain-lain
- 3.6.8. Penyimpanan instrumen atau peralatan steril  
Penyimpanan instrumen atau peralatan steril dengan benar sangat penting untuk menjaga tetap steril. Oleh karena itu perlu ditulis tanggal sterilisasi dan tanggal kedaluwarsa pada bungkus alat yang steril sebelum penyimpanan.
- 3.7. **Etika Batuk atau Bersin**
  - 3.7.1. Pastikan dan ajarkan petugas, pasien/donor, pengunjung melakukan kebersihan pernapasan/etika batuk apabila mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, flu dan bersin.
  - 3.7.2. Lakukan prosedur kebersihan pernapasan/etika batuk saat anda flu atau batuk, gunakan masker bedah dengan baik dan benar agar orang lain tidak tertular
  - 3.7.3. Tersedia tempat cuci tangan di fasilitas kesehatan, setelah melakukan etika batuk dengan benar, lakukan cuci tangan 6 (enam) langkah dengan benar
  - 3.7.4. Tidak menggantungkan masker bekas atau dipakai pada leher karena bisa menyebar kembali virus dan bakteri ketika digunakan kembali
  - 3.7.5. Bila tidak tersedia masker bedah, gunakan metode lain untuk pencegahan dan pengendalian sumber patogen (misalnya sapu tangan, tisu, atau lengan bagian atas) saat bersin dan batuk.
- 3.8. **Pengelolaan Limbah Hasil Pelayanan Kesehatan**
  - 3.8.1. **Pengelolaan Limbah Infeksius**
    - 3.8.1.1. Limbah infeksius dimasukkan ke dalam tempat yang kuat, tahan air, dan mudah dibersihkan dengan kode infeksius/medis, di dalamnya dipasang kantong berwarna kuning atau jika tidak memungkinkan maka diberi label infeksius.
    - 3.8.1.2. Penempatan limbah infeksius diletakkan dekat area tindakan atau prosedur tindakan yang akan dikerjakan
    - 3.8.1.3. Limbah infeksius yang sudah menempati  $\frac{1}{4}$  kantong sampah segera diangkat dan diikat kuat dan tidak boleh dibuka lagi untuk mengeluarkan isinya guna menghindari risiko penularan infeksi, selanjutnya dibawa ke tempat penampungan sementara. Tempat limbah dicuci dengan menggunakan

DAFTAR TERKENDALI

NO : 001

MASTER

|                                                                                                                                           |                                                                                   |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 15 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

larutan detergen atau desinfektan sesuai instruksi pabrikan, lalu dikeringkan selanjutnya dipasang kembali kantong plastik kuning yang baru.

- 3.8.1.4. Limbah Infeksius, patologis, benda tajam harus disimpan pada TPS dengan suhu dan lama penyimpanan sebagai berikut:
  - Pada suhu lebih kecil atau sama dengan 0°C dalam waktu sampai dengan 90 hari.
  - Jika suhu 3°C -8°C dapat disimpan sampai dengan 7 hari.
- 3.8.1.5. Limbah yang sangat infeksius seperti biakan dan persediaan agen infeksius dan laboratorium harus disterilisasi dengan pengolahan dan basah seperti dalam autoklaf sebelum dilakukan pengolahan.
- 3.8.1.6. Limbah pada farmasi dalam jumlah besar harus dikembalikan kepada distributor atau gudang farmasi kabupaten/kota, sedangkan bila dalam jumlah sedikit dan tidak memungkinkan dikembalikan dapat dimusnahkan menggunakan insinerator atau dikelola oleh perusahaan pengolahan limbah B3 atau dimusnahkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3.8.1.7. Limbah sitotoksik sangat berbahaya dan dilarang dibuang dengan cara penimbunan (*land fill*) maupun dibuang ke saluran limbah umum. Pengolahan dilakukan dengan cara dikembalikan ke perusahaan atau distributornya atau dilakukan pengolahan dengan insinerator pada suhu tinggi 1.000°C s/d 1.200°C untuk menghancurkan semua bahan sitotoksiknya.
- 3.8.1.8. Pengolahan limbah kimia biasa dalam jumlah kecil maupun besar harus diolah ke perusahaan limbah B3. Bahan kimia dalam bentuk cair sebaiknya dibuang ke jaringan pipa pembuangan air limbah, karena sifat toksiknya dapat mengganggu proses biologi yang akan dalam unit pengolahan air limbah atau IPAL.
- 3.8.1.9. Pembuangan akhir limbah infeksius dapat dimusnahkan dengan insenerator atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Jika bekerja sama dengan pihak ketiga maka pastikan mereka memiliki perizinan, fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.8.2. Pengelolaan Limbah non-Infeksius
  - 3.8.2.1. Limbah non infeksius (non medis) ditempatkan dalam tempat yang kuat, mudah dibersihkan pada tempat sampah berlabel limbah non infeksius.

DOKUMEN TERKENDALI

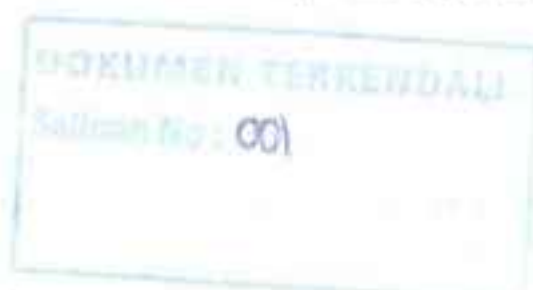
Salinan No. 001

TRASTE



|                                                                                                                                           |                                                                                   |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 16 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

- 3.8.2.2. Tempatkan kantong plastik berwarna hitam atau kantong plastik dengan label non infeksius.
- 3.8.2.3. Limbah non infeksius harus diangkat dan dikosongkan setelah  $\frac{3}{4}$  kantong kemudian diikat untuk dibawa ke tempat penampungan sementara dan tempat limbah tersebut dibersihkan selanjutnya dipasang kantong plastik hitam yang baru.
- 3.8.2.4. Pembuangan akhir limbah non infeksius dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintahan daerah setempat.
- 3.8.3. Pengelolaan Limbah Benda Tajam
  - 3.8.3.1. Semua limbah benda tajam dimasukkan ke dalam kotak benda tajam (*safety box*) yang kuat, tahan air, tahan tusukan, berwarna kuning atau kotak benda tajam yang diberi limbah benda tajam.
  - 3.8.3.2. Penempatan *safety box*, pada area yang aman dan mudah dijangkau atau digantung pada troli tindakan, tidak menempatkan *safety box* di lantai.
  - 3.8.3.3. Pembuangan *safety box* dilakukan setelah kotak terisi  $\frac{2}{3}$  dengan menutup rapat permukaan lobang box agar jarum tidak dapat keluar, jika dibuang dengan waktu yang lama maka penggunaan *safety box* sesuai ukuran atau sesuai kebijakan FTKP yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  - 3.8.3.4. Pembuangan akhir limbah benda tajam dapat dilakukan melalui pembakaran di insenerator atau dikelola sama dengan limbah B3 lainnya.
- 3.8.4. Pengelolaan Limbah Cair
  - 3.8.4.1. Limbah cair yang bersala dari seluruh sumber bangunan atau kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan harus diolah melalui unit pengolah limbah cair (IPAL). Efluen limbah cair harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 3.8.4.2. Limbah cair seperti feses, urin dan darah dibuang pada pembuangan atau pojok limbah
  - 3.8.4.3. Pastikan terdapat tempat penampungan limbah sementara yang terpisah atau terletak di luar area pelayanan dengan ruangan tertutup penyimpanan limbah tidak menempel pada lantai (diberi jarak menggunakan pallet), dilakukan pembersihan secara rutin serta dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



|                                                                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI) |                               | Halaman 17 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                              | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

3.8.4.4. Jika pembuatan limbah di akhir bekerja sama dengan pihak ketiga, pastikan pembungannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.9. **Penatalaksanaan Pasca Pajanan Benda Tajam**

Setiap kejadian pasca pajanan benda tajam hendaknya dilaporkan dan dilakukan tindak lanjut berupa pengawasan pada petugas yang terpajan.

3.10. **Surveilans penyakit**

UDD harus melakukan surveilans infeksi berdasarkan data epidemiologis yang terjadi dan berfokus pada area infeksius, penggunaan peralatan, prosedur serta praktik untuk mencegah dan menurunkan angka infeksi.

UDD harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap semua petugas baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan. Selain itu, terdapat proses apabila terjadi tusukan jarum atau benda tajam bekas pakai donor, siapa yang harus dihubungi saat terjadi kecelakaan dan pemeriksaan serta konsultasi yang dibutuhkan oleh petugas yang bersangkutan. Petugas harus diberi edukasi agar paham terhadap proses untuk menghindari terjadinya kecelakaan serta apa yang harus dilakukan apabila kecelakaan tersebut terjadi. Tidak melakukan penutupan kembali (*recap*) jarum yang telah dipakai, memanipulasi dengan tangan, menekuk, mematahkan atau melepas jarum dari spuit. Buang jarum, spuit, pisau, *scalpet*, dan peralatan tajam habis pakai lainnya ke dalam wadah khusus yang tahan tusukan/tidak tembus sebelum dimasukkan ke insenerator. Bila wadah khusus telah terisi  $\frac{3}{4}$  bagian, maka harus diganti dengan yang baru untuk menghindari adanya jarum atau benda tajam yang tercecer.

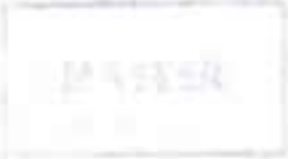
Sebagian besar insiden paparan/pajanan okupasional adalah infeksi melalui darah, HIV, hepatitis B, dan hepatitis C adalah patogen melalui darah yang berpotensi paling berbahaya, dan kemungkinan paparan/pajanan terhadap patogen ini merupakan penyebab utama kecemasan bagi petugas kesehatan di seluruh dunia.

3.11. **Penyusunan *Infection Control Risk Assesment* (ICRA)**

ICRA adalah sistem yang digunakan untuk menilai bahaya dari infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien, keluarga, petugas, pengunjung, dan lingkungan.

Langkah Pengkajian ICRA Program:

- 3.10.1. Identifikasi masalah
- 3.10.2. Analisa Risiko
- 3.10.3. Penilaian dan penentuan skoring
- 3.10.4. Pengelolaan risiko
- 3.10.5. *Plan of action*
- 3.10.6. Evaluasi Risiko





|                                                                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI) |                               | Halaman 18 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                              | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

3.12. Penilaian Probabilitas

| No. | DESKRIPSI | FREKUENSI KEJADIAN                                                                                             |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Very Low  | 0-5% hampir tidak mungkin terjadi (terjadi dalam lebih dari 5 tahun)                                           |
| 2.  | Low       | Jarang (1-2x/tahun)<br>Jarang tapi bukan tidak mungkin terjadi (terjadi dalam jangka waktu 2-5 tahun)          |
| 3.  | Medium    | 31-70%<br>Kadang (frekuensi 3-4x/tahun). Mungkin terjadi/bisa terjadi (dapat terjadi tiap 1-2 tahun)           |
| 4.  | High      | Agak sering (frekuensi 4-6/tahun)<br>Sangat mungkin terjadi (terjadi setiap bulan/beberapa kali dalam setahun) |
| 5.  | Very High | Sering (frekuensi >6x/tahun). Hampir pasti akan terjadi (terjadi dalam minggu/bulan)                           |

3.13. Penilaian Dampak

| TINGKAT RISIKO | DESKRIPSI                         | DAMPAK                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.             | Minimal Klinis                    | Tidak ada cedera                                                                                                                                                                      |
| 2.             | Moderate Klinis                   | Cedera ringan, misalnya lecet, dapat diatasi dengan P3K.                                                                                                                              |
| 3.             | Lama Hari rawat Panjang           | Cedera sedang (luka robek), berkurangnya fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual tidak berhubungan dengan penyakitnya dan setiap kasus akan memperpanjang hari perawatan. |
| 4.             | Kehilangan fungsi tubuh sementara | Cedera luas/berat (cacat atau lumpuh), kehilangan fungsi motorik/sensorik/psikologis/intelektual) tidak berhubungan dengan penyakit.                                                  |
| 5.             | Katastropik                       | Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit.                                                                                                                           |

DOKUMEN TERKENDALI  
Salinan No: 001

KATASTROPIS

|                                                                                                                                                      |                                                                                   |                               |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 19 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                                      | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

3.14. Penilaian Sistem

| TINGKAT<br>RISIKO | DESKRIPSI    | SISTEM, PERATURAN, DAN PELAKSANAAN                      |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1.                | <i>Solid</i> | Peraturan ada, fasilitas ada, dilaksanakan              |
| 2.                | <i>Good</i>  | Peraturan ada, fasilitas ada, tidak selalu dilaksanakan |
| 3.                | <i>Fair</i>  | Peraturan ada, fasilitas ada, tidak dilaksanakan        |
| 4.                | <i>Poor</i>  | Peraturan ada, fasilitas tidak ada, tidak dilaksanakan  |
| 5.                | <i>Non</i>   | Tidak ada peraturan                                     |

- 3.15. Penilaian dan Penentuan Skor
- Nilai dari probabilitas X nilai Dampak X Nilai Sistem
- Program prioritas berdasarkan nilai terbesar.

4. Referensi

- 4.1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 4.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.3. Modul Mata Pelatihan Dasar 2 Management Sumber Daya Penerapan PPI di FTKP tahun 2021
- 4.4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1. Pencegahan dan pengendalian infeksi adalah suatu upaya kegiatan untuk mencegah, meminimalkan kejadian infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang meliputi pengkajian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- 5.2. Infeksi adalah suatu keadaan di mana ditemukan adanya agen infeksi (organisme), terdapat respon imun tetapi dan gejala klinik.
- 5.3. Penyakit Infeksi adalah suatu keadaan di mana ditemukan adanya agen Infeksi yang disertai adanya respon imun dan gejala klinik.
- 5.4. Penyakit infeksius adalah penyakit (infeksi) tertentu yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.5. Infeksi terkait pelayanan kesehatan *Healthcare Associated Infections* (HAIs) adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, di mana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang, infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan yang terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.





|                                                                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI) |                               | Halaman 20 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                              | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

- 5.6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana (tempat dan alat) yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 5.7. Alat Pelindung Diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja.
- 5.8. *Hand Hygiene* (cuci tangan) adalah suatu prosedur tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan air mengalir dengan sabun antiseptik untuk meminimalkan risiko penyebaran infeksi.
- 5.9. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa.
- 5.10. Desinfektan adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung namun tidak memiliki penetrasi sehingga tidak mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat dalam celah atau cemaran mineral.
- 5.11. Desinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat dipermukaan benda mati.
- 5.12. Dekontaminasi adalah proses pembersihan suatu benda atau zat untuk menghilangkan zat pencemar seperti mikroorganisme atau bahan berbahaya termasuk bahan kimia, zat radioaktif, dan penyakit berjangkit.
- 5.13. Sterilisasi adalah upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Desinfeksi merupakan proses untuk merusak organisme yang termasuk patogen, namun tidak dapat mengeliminasi dalam bentuk spora (Tille, 2017).
- 5.14. Sterilisator adalah alat yang berfungsi untuk mensterilkan suatu peralatan medis dengan memanfaatkan metode perubahan energi listrik menjadi energi panas.
- 5.15. Limbah medis adalah limbah yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh manusia, jarum suntik, dan bahan-bahan medis yang beresiko menularkan penyakit.
- 5.16. Limbah medis cair adalah limbah infeksius yang berupa cairan seperti darah, plasma dan komponen lainnya serta cairan pembuangan hasil pemeriksaan IMLTD.
- 5.17. Limbah medis padat adalah limbah infeksius yang dapat berupa Jarum suntik, kantong darah, dan tabung bekas sample darah donor dan sample pasien.
- 5.18. Limbah non medis adalah limbah yang dihasilkan dari poses pelayanan darah tetapi tidak mempunyai sifat infeksius.
- 5.19. Limbah berbahaya dan beracun adalah limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.





|                                                                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI) |                               | Halaman 21 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                              | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

- 5.20. IPAL adalah Instalasi Pengelolaan Air Limbah, sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan untuk aktivitas.
- 5.21. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelohan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 5.22. Refrigerator limbah adalah kulkas penyimpanan dengan suhu tertentu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan limbah darah.
- 5.23. Surveilans adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus, komprehensif dan dinamis berupa perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, komunikasi dan evaluasi dari data kajian infeksi yang dilaporkan secara berkala kepada pihak yang berkepentingan pada strategi pencegahan dan pengendalian infeksi.
- 5.24. *Infections Control Risk Assement (ICRA)* adalah penilaian risiko pengendalian infeksi yang merupakan proses multidisiplin yang berfokus pada pengurangan risiko dari infeksi ke pasien, perencanaan fasilitas, desain, dan konstruksi kegiatan.
- 5.25. Kewaspadaan isolasi adalah tindakan pencegahan atau pengendalian infeksi yang harus diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan maksud untuk menurunkan risiko transmisi penyakit dari pasien ke petugas kesehatan, pengunjung, masyarakat sekitarnya tau sebaliknya.
- 5.26. Kewaspadaan standar adalah kewaspadaan yang utama, dirancang untuk diterapkan secara rutin dalam perawatan seluruh pasien di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang telah didiagnosa, diduga terinfeksi atau kolonisasi.
- 5.27. Kewaspadaan transmisi adalah lapis kedua dari kewaspadaan isolasi yaitu tindakan pencegahan dan pengendalian Infeksi yang dilakukan pada saat memberikan infeksinya. Kewaspadaan ini diterapkan untuk mencegah dan memutus rantai penularan penyakit lewat kontak, droplet, udara, vetikulum, dan vektor (serangga atau binatang pengerat).

6. Peran dan Tanggung Jawab

| Peran            | Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala UDDP      | <ul style="list-style-type: none"><li>Bertanggung jawab terhadap semua kebijakan terkait dengan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Unit Donor Darah Pusat PMI</li><li>Menunjuk Tim untuk pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)</li></ul> |
| Manajer Kualitas | <ul style="list-style-type: none"><li>Meninjau ulang dokumen SPO dan formulir yang terkait dengan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)</li><li>Memastikan dokumen SPO yang terkait dapat digunakan</li></ul>                                                  |





|                                                                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI) |                               | Halaman 22 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                              | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

| Peran           | Tanggung Jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Memastikan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Koordinator PPI | <ul style="list-style-type: none"><li>Memeriksa dokumen terkait</li><li>Menindaklanjuti laporan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Anggota Tim PPI | <ul style="list-style-type: none"><li>Membuat dan memperbaharui SPO, Instruksi kerja, dan formulir yang terkait</li><li>Menyerahkan pembaharuan SPO kepada Kepala Bagian untuk diperiksa</li><li>Melaporkan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li><li>Mensosialisasikan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) kepada seluruh pihak yang terkait</li></ul> |

7. Alat dan Bahan

7.1. Alat

- 7.1.1. Alat Pelindung Diri (APD)
- 7.1.2. Tempat Cuci tangan
- 7.1.3. Sterilisator
- 7.1.4. Troli Kebersihan
- 7.1.5. Tempat sampah medis
- 7.1.6. Tempat sampah non medis
- 7.1.7. Tempat limbah infeksius
- 7.1.8. Tempat limbah tajam
- 7.1.9. Sapu
- 7.1.10. Sekop
- 7.1.11. Alat perbersih langit-langit
- 7.1.12. Kain pel
- 7.1.13. Safety box
- 7.1.14. Pinset

7.2. Bahan

- 7.2.1. Alkohol 70%
- 7.2.2. Alkohol swab 70%
- 7.2.3. Handrub
- 7.2.4. Gliserin
- 7.2.5. Klorin 0,5%
- 7.2.6. Enzymatik cleaner 0,8%
- 7.2.7. Detergen
- 7.2.8. Natrium Hypoclorit 5,25% (untuk proses DTT)

|                                                                                                                                                      |                                                                                   |                               |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 23 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                                      | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

- 7.2.9. Kantong plastik sesuai dengan jenis limbah
- 7.2.10. Kasa steril
- 7.2.11. *Povidone Iodine*
- 7.2.12. Tisu kering

## 8. Prosedur

### 8.1. Kebersihan Tangan atau *Hand Hygiene*

*Hand Hygiene* dapat dilakukan dengan melakukan handwash (basuh dengan air mengalir) jika tangan tampak kotor atau dengan handrub (cairan antiseptic) jika tangan tidak tampak kotor. Langkah dalam melakukan hand hygiene mengacu pada IK Kebersihan Tangan (UDDP-MK-L3-003).

### 8.2. Kebersihan Lengan Donor

Lakukan cuci lengan pada donor yang lolos proses seleksi baik pemeriksaan Hb dan golongan darah maupun kesehatan sederhana oleh dokter atau petugas yang diberi wewenang. Langkah dalam melakukan cuci lengan donor mengacu pada IK Cuci Lengan Donor (UDDP-PDD-L3-005).

### 8.3. Desinfeksi Lengan Donor

Lakukan desinfeksi lengan donor sebelum dilakukan penusukan mengacu pada IK Pengambilan Darah Konvensional (UDDP-PDD-L3-007).

### 8.4. Penggunaan APD

Gunakan APD sesuai dengan indikasi penggunaan APD sebelum melakukan tindakan yang berisiko terpapar bahan atau cairan yang bersifat infeksius dengan mengacu pada IK Penggunaan APD (UDDP-MK-L3-004).

### 8.5. Kewaspadaan Transmisi

#### 8.5.1. Kewaspadaan transmisi kontak

8.5.1.1. Lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pengguna layanan sesuai dengan lima momen indikasi kebersihan tangan.

8.5.1.2. Jika diperlukan, minta pengguna layanan melakukan kebersihan tangan sebelum mendapatkan pelayanan.

8.5.1.3. Kenakan gaun saat memberikan pelayanan langsung kepada pengguna layanan. Lepaskan tanpa menyentuh area yang terkontaminasi. Buang limbah infeksius sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

8.5.1.4. Kenakan sarung tangan sekali pakai saat memberikan pelayanan.

8.5.1.5. Lepaskan sarung tangan tanpa menyentuh area yang terkontaminasi buang sebagai limbah infeksi.

#### 8.5.2. Kewaspadaan transmisi droplet

8.5.2.1. Pastikan semua petugas mematuhi prosedur kewaspadaan standar yang telah ditetapkan saat akan memberikan pelayanan.





|                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                       |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><br><b>Unit Donor Darah Pusat</b> | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                                       | Halaman 24 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                                      | <b>Bidang<br/>Manajemen Kualitas</b>                                              | <b>Sub Bidang<br/>Kontrol Dokumen</b> |                                                                                                                                |

- 8.5.2.2. Lakukan kebersihan tangan sebefore dan sesudah kontak pengguna layanan dengan menggunakan air dan sabun atau cairan *handrub* berbasis alkohol.
- 8.5.2.3. Gunakan masker jika ada gangguan saluran pernapasan (batuk, flu, dan lain-lain)
- 8.5.2.4. Pengguna layanan diajarkan kebersihan tangan dan etika batuk.
- 8.5.2.5. Gunakan alat pelindung diri seperti masker, kacamata atau pelindung wajah, menggunakan gaun
- 8.5.3. Kewaspadaan transmisi udara (*airbone*)
  - 8.5.3.1. Lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pengguna layanan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau *handrub* berbahan dasar alkohol
  - 8.5.3.2. Gunakan alat pelindung diri seperti masker, kacamata, atau pelindung wajah dan gaun
  - 8.5.3.3. Gunakan ruangan dengan ventilasi tekanan negatif, jika tidak memungkinkan dapat menggunakan ventilasi tekanan mekanik atau ventilasi natural dan pintu harus selalu tertutup
  - 8.5.3.4. Lakukan edukasi kepada pengguna layanan agar menjaga kebersihan tangan dan menjalankan kewaspadaan isolasi untuk mencegah penyebaran infeksi.
  - 8.5.3.5. Pembersihan dan desinfeksi ruangan yang benar perlu dilakukan.

**8.6. Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan**

- 8.6.1. Lakukan pembersihan tumpahan cairan infeksius dengan cara berikut:
  - 8.6.1.1. Gunakan APD (topi, sarung tangan, kacamata, masker, jas lab/gaun) oleh Petugas yang melakukan pembersihan tumpahan
  - 8.6.1.2. Beri tanda untuk menunjukkan area adanya tumpahan.
  - 8.6.1.3. Serap cairan yang tumpah dibersihkan dengan kain perca/handuk/tisu/koran bekas penyerap bersih yang dapat menyerap sampai bersih kemudian buang ke kantong warna kuning (kantong infeksius)
  - 8.6.1.4. Tuangkan cairan detergen kemudian serap dengan kain perca/handuk/tisu/koran bekas masukan ke kantong warna kuning
  - 8.6.1.5. Lanjutkan dengan cairan klorin 0,5% kemudian serapan dan buang ke kantong warna kuning (kantong infeksius)
- 8.6.2. Lakukan pembersihan tumpahan cairan B3 dengan langkah berikut:
  - 8.6.2.1. Gunakan APD (topi, sarung tangan, kacamata, masker, jas lab/gaun) oleh Petugas yang melakukan pembersihan tumpahan

DOKUMEN TERKENDALI  
Salinan No : 001



|                                                                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI) |                               | Halaman 25 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                              | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

- 8.6.2.2. Beri tanda untuk menunjukkan area adanya tumpahan
- 8.6.2.3. Jika tumpahannya adalah bahan kimia: tuangkan air bersih pada tumpahan, lalu keringkan dengan kertas/koran/kain perca kemudian masukan ke kantong warna coklat, tuangkan detergen dan serap/keringkan dengan keras/koran/kain perca buang ke kantong warna coklat. Berikan label B3 pada plastik warna coklat tumpahan kimia.
- 8.6.2.4. Jika tumpahannya adalah reagen: lokalisir area tumpahan dengan menaburkan Natrium Bicarbonat sekitar area tumpahan, kumpulkan bekas resapan ke dalam plastik coklat.
- 8.6.2.5. Buang plastik sampah infeksius ke tempat penampungan sampah infeksius dan kumpulkan limbah tumpahan B3 dalam ruang penyimpanan limbah B3.

8.7. Pengelolaan Peralatan

- 8.7.1. Gunakan APD oleh petugas yang melakukan pengelolaan peralatan
- 8.7.2. Proses *Pre-Cleaning* semua alat medis yang telah digunakan dilakukan pembersihkan dengan merendam seluruh permukaan peralatan medis menggunakan *enzimatik cleaner 0,8%* atau detergen selama 10-15 menit
- 8.7.3. Bersihkan bila ada noda darah atau kotoran dengan sikat sesuai dengan indikasi alat
- 8.7.4. Bilas dengan air mengalir dengan suhu 40°C - 50°C, kemudian tiriskan untuk proses selanjutnya
- 8.7.5. Kemas dengan cara bungkus dengan kertas khusus atau kain alat sesuai disterilkan
- 8.7.6. Berikan label nama alat, tanggal, pengemasan, metode sterilisasi, tipe dan ukuran alat yang dikemas, penempatan alat dalam kemasan
- 8.7.7. Gunakan sterilisasi pemasan kering pada temperatur 120°C - 170°C dalam waktu 1 jam sampai 2 jam
- 8.7.8. Simpan peralatan yang sudah disteril dengan benar tulis tanggal sterilisasi dengan tanggal kedaluwarsa pada bungkus alat steril sebelum penyimpanan.
- 8.7.9. Untuk peralatan non kritikal dilakukan pencucian dengan detergen dan air yang mengalir kemudian keringkan dengan cara digantung, seperti manset tensimeter.
- 8.7.10. Desinfeksi dengan menggunakan alkohol swab 70% seperti stetoskop, termometer.
- 8.7.11. Catat tiap kali melakukan sterilisasi alat pada Formulir Sterilisasi Alat (UDDP-MK-L4-057)





|                                                                                                             |                                                                                   |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Unit Donor Darah Pusat | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 26 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                             | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

## 8.8. Pengelolaan Limbah

- 8.8.1. Lakukan *hand hygiene* saat melakukan pengelolaan limbah
- 8.8.2. Gunakan APD sesuai indikasi tempat yang akan dibersihkan
- 8.8.3. Lakukan pemusnahan darah, komponen darah dan sampel sisa pengujian dengan cara:
  - 8.8.3.1. Buang sampel sisa pengujian IMLTD dan Konfirmasi Golongan Darah ke dalam tempat limbah infeksius
  - 8.8.3.2. Musnahkan darah dan komponen darah dan dokumentasikan dalam Berita Acara Pemusnahan Darah (UDDP-MK-L4-050), jika:
    - Hasil reaktif, plasma dapat diberikan kepada bagian IMLTD sebagai bahan dalam pembuatan sel panel sedangkan komponen darah lainnya dimusnahkan oleh bagian Pengolahan Komponen dan disaksikan oleh petugas IMLTD
    - Tidak Lulus Pelulusan Produk, maka darah dan komponen darah dimusnahkan oleh petugas Pelulusan Produk dan disaksikan oleh petugas pengolahan komponen
    - Kedaluwarsa, gagal aftar dan lain-lain, maka darah dan komponen darah dimusnahkan oleh petugas penyediaan darah dan disaksikan oleh petugas Pelulusan Produk
- 8.8.4. Pastikan limbah cair yang dibuang ke wastafel terhubung dengan saluran IPAL
- 8.8.5. Pastikan IPAL yang digunakan telah dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan yang terdokumentasi dalam Formulir Pemeliharaan IPAL (UDDP-MK-L4-049)
- 8.8.6. Pastikan IPAL yang digunakan diperiksa setiap bulan terhadap parameter tertentu yang terlampir dalam Formulir Pemeriksaan IPAL (UDDP-MK-L4-031)
- 8.8.7. Pilah limbah infeksius dan non infeksius yang sudah dipisahkan
- 8.8.8. Buang limbah non infeksius terlebih dahulu untuk meminimalkan risiko penyebaran infeksi ke tempat pembuangan sementara
- 8.8.9. Bersihkan dan cuci tempat sampah non infeksius setelah dikeringkan, pasang kembali dengan kantong plastik yang baru (warna hitam)
- 8.8.10. Setelah penanganan limbah non infeksius selesai, lanjutkan untuk penanganan limbah infeksius.
- 8.8.11. Lakukan *hand hygiene* saat melakukan pengelolaan limbah
- 8.8.12. Gunakan APD sesuai indikasi tempat yang akan dibersihkan
- 8.8.13. Buang limbah medis dilakukan pada jam 06.00-07.00 WIB sebelum karyawan datang. Untuk meminimalkan risiko penyebaran infeksi.
- 8.8.14. Bersihkan limbah yang sudah ditempatkan pada tempat khusus limbah sesuai jenis limbah sesuai jenis limbah yang dihasilkan oleh petugas kebersihan

DOKUMEN TERKENDALI  
Salinan No 1

MASTER

|                                                                                                                                           |                                                                                   |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | <b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br/>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)</b> |                               | Halaman 27 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                                      | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

- 8.8.15. Pastikan kantong limbah sudah terikat dengan kuat, jangan dibuka kembali.
- 8.8.16. Alur limbah melalui yang sudah ditentukan, jika sudah memakai *pasbox*, petugas membersihkan *pasbox* yang sudah dilewati limbah dengan cairan hipoklorit (0,5%).
- 8.8.17. Angkut limbah infeksius dengan menggunakan troli pengangkut tertutup.
- 8.8.18. Bedakan troli limbah infeksius dengan troli limbah non infeksius.
- 8.8.19. Bersihkan dan cuci kembali tempat limbah infeksius, setelah kering pasang kembali kantong plastik baru (warna kuning).
- 8.8.20. Angkut limbah infeksius ke tempat pembuangan sementara yang sudah disediakan.
- 8.8.21. Buang limbah infeksius pada tempatnya sesuai dengan jenis limbah (pada, cair, dan tajam).
- 8.8.22. Lakukan dokumentasi pengolahan limbah infeksius akan diangkut oleh transporter dari pihak ke tiga yang sudah memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
  - 8.8.19.1. Pada saat limbah dikumpulkan dan dikeluarkan dari tempat penampungan limbah infeksius sementara isi Formulir Logbook Pengelolaan Limbah B3 (UDDP-MK-L4-032).
  - 8.8.19.2. Pada saat limbah diserahkan kepada pihak ke tiga isi Formulir Serah Terima Limbah (UDDP-MK-L4-033).
- 8.8.23. Lakukan observasi pengelolaan limbah setiap bulan sekali oleh Petugas K3/PPI dengan mengisi Formulir Observasi Pengelolaan Limbah (UDDP-MK-L4-035)
- 8.8.24. Setelah petugas melakukan penanganan limbah dengan baik dan benar, petugas melepaskan APD sesuai ketentuan dan melakukan kebersihan tangan
- 8.9. **Penatalaksanaan Pasca Pajanan Benda Tajam**
  - 8.9.1. Lakukan penatalaksaian pasca pajanan benda tajam sesuai IK Penatalaksanaan Pasca Pajanan Benda Tajam (UDDP-MK-L3-006)
  - 8.9.2. Lakukan pelaporan kejadian pasca pajanan benda tajam pada Formulir Pelaporan Pasca Pajanan Benda Tajam (UDDP-MK-L3-052)

9. Dokumen Terkait

- |                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 9.1. IK Kebersihan Tangan                         | (UDDP-MK-L3-003)  |
| 9.2. IK Cuci Lengan Donor                         | (UDDP-PDD-L3-005) |
| 9.3. K Pengambilan Darah Konvensional             | (UDDP-PDD-L3-007) |
| 9.4. IK Penggunaan APD                            | (UDDP-MK-L3-004)  |
| 9.5. IK <i>Spill Kit</i>                          | (UDDP-MK-L3-005)  |
| 9.6. IK Penatalaksanaan Pasca Pajanan Benda Tajam | (UDDP-MK-L3-006)  |





|                                                                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Palang Merah Indonesia<br><br>Unit Donor Darah Pusat | STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL<br>PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI) |                               | Halaman 28 dari 28<br>Nomor : UDDP-MK-L2-022<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku: 28 Jun 2024<br>Tanggal kaji ulang: 28 Jun 2026 |
|                                                                                                                                           | Bidang<br>Manajemen Kualitas                                              | Sub Bidang<br>Kontrol Dokumen |                                                                                                                                |

10. Lampiran

|        |                                                                   |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10.1.  | Berita Acara Pemusnahan Darah                                     | (UDDP-MK-L4-050) |
| 10.2.  | Formulir Pemeliharaan IPAL                                        | (UDDP-MK-L4-049) |
| 10.3.  | Formulir Pemeriksaan IPAL                                         | (UDDP-MK-L4-031) |
| 10.4.  | Formulir Logbook Pengelolaan Limbah B3                            | (UDDP-MK-L4-032) |
| 10.5.  | Fomulir Serah Terima Limbah                                       | (UDDP-MK-L4-033) |
| 10.6.  | Formulir Observasi Pengelolaan Limbah                             | (UDDP-MK-L4-035) |
| 10.7.  | Formulir Observasi Kepatuhan Kebersihan Tangan dan Penggunaan APD | (UDDP-MK-L4-040) |
| 10.8.  | Formulir Dekontaminasi Meja Kerja dan Alat                        | (UDDP-MK-L4-051) |
| 10.9.  | Formulir Pelaporan Paparan Benda Tajam                            | (UDDP-MK-L4-052) |
| 10.10. | Formulir Sterilisasi Alat                                         | (UDDP-MK-L4-057) |

11. Riwayat Dokumen

| Versi | Tanggal      | Referensi                                                                                            | Riwayat Perubahan |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 001   | 28 Juni 2024 | PMK Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pencegahan Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Dokumen Baru      |

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI  
Salinan 7/10 :